

«Інфекційний мононуклеоз»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- в'яснити анамнез захворювання (у т.ч. епідеміологічний та парентеральний) анамнез та анамнез життя;
- продемонструвати практичну навичку “Пальпація лімфатичних вузлів”;
- виділити провідний синдром;
- означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових досліджень:

3. Сценарій «Збір скарг та анамнезу, об'єктивне обстеження хворого з діагнозом інфекційний мононуклеоз».

4. Додаток 1. Об'єктивне обстеження пацієнта

Стан середньо тяжкий, температура 39°C, обличчя одутле, носом не дихає, голос із гугнявим відтінком, склери субіктеричні. У ротоглотці –яскрава гіперемія, на збільшених піднебінних мигдаликах суцільні накладання біло-жовтого кольору. Язик густо обкладений білим нальотом. Дихання везикулярне. ЧД - 18 за хв. Тахікардія 100 за хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка та селезінка виступають з-під краю реберної дуги на + 3 см. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

5. Додаток 1.Характеристика лімфовузлів

Під час пальпації передньошийні, задньошийні та пахові лімфовузли збільшені 2 см в діаметрі з обох боків, щільно еластичні й помірно болючі. Розміри інших лімфовузлів до 3-4 см.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви – лікар приймального відділення. До Вас звернувся хлопець.

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти	Текст стандартизованого пацієнта
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
Привітатися з	Доброго дня.	Доброго дня.

<i>пацієнтом</i>		
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікар-терапевт, Володимир Іванович.	Дуже приємно.
<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Петро
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	17 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви навчаєтесь чи працюєте?	Я студент.
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
<i>Інформувати пацієнта про «лікарську таємницю»</i>	Наша розмова конфіденційна, можете мені довіритися.	Добре.
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Петре, що Вас турбує?	Підвищення температура тіла до 39°C, біль у горлі, слабкість.
	Температура постійно висока чи підвищується ввечері?	Постійно.
	Петре, Ви щось приймали для зниження температури?	Так, парацетамол. Ліки знижували температуру до 37,6 °C на кілька годин.
<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	Коли Ви захворіли?	Тиждень тому.
	Розкажіть будь ласка з чого все почалося?	Спочатку підвищилась температура до 38°C, потім з'явилися болі при ковтанні.
	Ви до лікаря звертались за допомогою?	Так. Мені діагностували гострий тонзиліт та призначили еритроміцин.
	Що зараз Вас змусило звернутися до лікаря?	Мені не допомагає лікування: температура не знижується, горло болить, і шия припухла з обох боків, заклало ніс.
<i>Запитати</i>	Петре, чи були випадки	Мій одноклассник теж

<i>епідеміологічний анамнез:</i>	подібних захворювань серед близьких та знайомих?	хворів: у нього теж боліло горло і підвищувалася температура тіла.
<i>Запитати парентеральний анамнез:</i>	У Вас були протягом місяця такі маніпуляції як видалення зуба, внутрішньовенні ін'єкції, тощо?	Ні.
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ, у дитинстві хворів ангіною.
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет ?	Ні
	Операції, травми протягом життя?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків?	Ні
	Шкідливі звички? Вживання ін'єкційних психотропних препаратів?	Ні
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>	Петре, зараз я Вам проведу пальпацію лімфовузлів, будь ласка зніміть одяг.	Так, зараз.
ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді.		
<i>Провести пальпацію лімфовузлів</i>	Візуальне оцінювання стану лімфатичних вузлів	В області шиї з обох боків, більше ліворуч, видно на око збільшені задньошийні та передньошийні лімфовузли, з деякою набряклістю навколо них
	Коректна пальпація лімфатичних вузлів (кінчиками пальців зробити ковзні кругові рухи в області передбачуваної локалізації лімфатичних вузлів)	

	Коректна послідовність пальпації лімфатичних вузлів (потиличні, завушні, підборіддя, підщелепні, передньошийні, задньошийні, надключичні, підключичні, пахові, ліктьові, пахові, підколінні)	
	Оцінювання характеру лімфатичних вузлів (в нормі не пальпуються): -локалізація; -розмір; -консистенція; -болючість; -зміщуваність (по відношенню до шкіри і оточуючих тканин); -зміна шкіри над лімфатичними вузлами.	Під час пальпації передньошийні, задньошийні та пахові лімфовузли збільшені 2 см в діаметрі з обох боків, щільно еластичні й помірно болючі. Розміри інших лімфовузлів до 3-4 см. (характеристика лімфовузлів додатково видається на папері).
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Уточнити самопочуття</i>	Як Ви себе відчуваєте, все добре? Одягайтеся.	Так. Добре.
<i>Пояснити подальші дії</i>	Петре, враховуючи наявність збільшення лимфовузлів, раджу Вам подальше дообстеження в стаціонарі для встановлення заключного діагнозу і призначення ліків.	Зрозумів.
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром – синдром лімфаденопатії.	
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Обмеження контактів і спільного використання предметів побуту з людьми Регулярне миття рук Дотримуватися правил	Дякую, лікарю.

	індивідуального використання засобів гігієни та косметики	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Петре, чи Вам все зрозуміло?	Все зрозуміла
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає
	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.